REVISE PARA PROVA · SEU RESUMO EM UMA ÚNICA FOLHA

Hérnias da Parede Abdominal

Conceitos, hérnias inguinais e femorais, conduta e outras hérnias em uma página

MAIS COBRADO

- **1º Direta × indireta**: vasos epigástricos
- **2º Redutível → encarcerada → estrangulada**
- **3º Femoral**: mulher e estrangula
- **4º Lichtenstein** é o padrão

1 Conceitos

peritônio e pele íntegros

Saída de órgão por ponto fraco da parede, dentro de um **saco peritoneal**. **Eventração** (pele íntegra) é hérnia; **evisceração** (pele e peritônio rotos) não é. ~5% da população terá hérnia.

75% são inguinais (2/3 indiretas) · incisionais 15–20% · umbilicais e epigástricas 10% · femorais ~5%. Homens: 25× mais inguinal. Mais à **direita** (processo vaginal fecha depois; sigmoide protege à esquerda).

Forma	O que é	Conduta
Redutível	Volta sozinha ou com manobra	Cirurgia **eletiva**
Encarcerada	Não reduz, sem sofrimento vascular	**Redução manual** com analgesia e Trendelenburg
Estrangulada	Sem circulação: isquemia e necrose	**Emergência** (enterectomia se necrose)

2 Hérnia inguinal

referência: vasos epigástricos inferiores

	Direta	Indireta
Onde	**Medial** aos vasos, no **triângulo de Hesselbach**	**Lateral** aos vasos, pelo anel inguinal interno
Mecanismo	Fraqueza do assoalho (parede posterior)	**Persistência do conduto peritônio-vaginal** (canal de Nuck na mulher)
Trajeto	Protrusão direta	Oblíquo, acompanha o cordão; pode ir ao escroto
Valsalva + dedo	Bate na **polpa**	Bate na **ponta**

Hesselbach: reto abdominal (medial), vasos epigástricos inferiores (lateral), ligamento inguinal (inferior). Risco: prematuridade, sexo masculino, história familiar, criptorquidia. Diagnóstico **clínico**; USG, TC ou RM na dúvida. Diferenciais: abscesso, aneurisma femoral, cisto de cordão.

3 Femoral, complicações e cirurgia

Femoral (crural): canal femoral, medial aos vasos femorais; trajeto estreito e rígido. Mais em **mulheres** e com a **maior taxa de estrangulamento**. Encarceram mais: indiretas e femorais. **Richter:** só a borda antimesentérica estrangula, sem obstrução clássica (pode necrosar e perfurar).

Bassini (com tensão) · **McVay** (ligamento de Cooper; boa na femoral) · **Lichtenstein** (tela, sem tensão: padrão) · **Stoppa** (tela pré-peritoneal grande). Complicações: trombose do plexo pampiniforme (atrofia testicular), lesão do **genitofemoral** (hiperestesia).

4 Outras hérnias

Umbilical: na criança, anel > 1 cm após 1 ano opera; no adulto, pressão (obesidade, gestação, ascite). **Epigástrica:** linha alba, muitas vezes múltipla, dor desproporcional; assintomática pode esperar. **Spieghel:** linha semilunar, abaixo do umbigo, intraparietal (difícil palpar), cirúrgica.

Incisional: 1–8% das laparotomias (14–20% nas contaminadas); obesidade, tosse crônica, incisão infraumbilical. **Lombares:** Grynfeltt (superior) e Petit (inferior). Pélvicas: obturadora, ciática, perineal. **Paraestomal:** complicação tardia de estomias.

Não confunda na prova

Os distratores que mais derrubam

1. **Evisceração não é hérnia:** pele e peritônio estão rotos.
2. **Direta é medial**, dentro de Hesselbach; indireta é lateral.
3. **Polpa = direta, ponta = indireta**, mas quem confirma é a cirurgia.
4. **Femoral é de mulher** e é a que mais estrangula.
5. **Richter** estrangula sem quadro obstrutivo.
6. **Encarcerada** tenta redução; estrangulada não, vai para a sala.
7. **McVay** usa o ligamento de Cooper; Lichtenstein usa tela.
8. **Mais à direita:** o processo vaginal fecha depois.
9. **Hérnia sem cirurgia** cresce e aumenta o risco de complicação.

Números que caem

75% inguinais · **2/3** indiretas · femorais **~5%**
Homem **25×** mais inguinal · umbilical > **1 cm** após **1 ano**
Incisional **1–8%** (14–20% contaminadas)

Elaborado pela MedSum com base no resumo de hérnias da parede abdominal do 8º semestre (aula de Clínica Cirúrgica; Sabiston; Schwartz; HerniaSurge 2018).